

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario de Salud del Paciente - 9 (PHQ-9)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Cuestionario de Salud del Paciente - 9
Sigla	PHQ-9
Autores	Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B.
Año	2001
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Depresión y anhedonia
Población	Adolescentes y adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme (Screening)
Disponibilidad en español	Sí (Baader et al., 2012)
Acceso/licencia	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Nota curatorial de derechos	Reproducción permitida; no se resolvió PDF directo estable.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Depresión y anhedonia. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	Unidimensional (basado en los 9 criterios del DSM para Depresión Mayor).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme (Screening)
Población objetivo	Adolescentes y adultos
Número de ítems	9 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 4 puntos de frecuencia en las últimas 2 semanas (0 = Nunca, a 3 = Casi todos los días).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	Unidimensional (basado en los 9 criterios del DSM para Depresión Mayor).
Ítems	9 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 4 puntos de frecuencia en las últimas 2 semanas (0 = Nunca, a 3 = Casi todos los días).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria directa (0 a 27 puntos).

Regla de corrección	Sumatoria directa (0 a 27 puntos).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntos de corte de severidad: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Moderadamente Severa), 20 (Severa).

Generalmente se usa >9 o >10 como corte diagnóstico.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Basado en criterios DSM-IV/5. Sensibilidad de 88% y especificidad de 88% para depresión mayor.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Basado en criterios DSM-IV/5. Sensibilidad de 88% y especificidad de 88% para depresión mayor.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Baader et al., 2012)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 3 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adolescentes y adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Depresión y anhedonia en Adolescentes y adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B.; 2001.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Baader et al., 2012)
- Trazabilidad local: 2 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Depresión y anhedonia
Población	Adolescentes y adultos
Estructura	Catálogo: 9 ítems.; Unidimensional (basado en los 9 criterios del DSM para Depresión Mayor).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria directa (0 a 27 puntos).
Interpretación	Puntos de corte de severidad: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Moderadamente Severa), 20 (Severa). Generalmente se usa >9 o >10 como corte diagnóstico.
Estado de fuentes	Locales válidos: 2; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Acceso abierto o uso permitido con condiciones; conservar atribución, versión y términos aplicables.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2001). Cuestionario de Salud del Paciente - 9.

Fuente de referencia del catálogo: [PHQ Screeners](https://www.phqscreeners.com/)

<https://www.phqscreeners.com/>

<https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x>

<https://www.phqscreeners.com/select-screener>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	PHQ-9 español (forma estadounidense 2005), 9 síntomas más pregunta funcional. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 54f8281d0df1854db7e9c9b54ed0fb0e015e877bfdc3750c8 609 164bf4b 87 201.
2. Población e informante	Ficha previa: Adolescentes y adultos. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Autoinforme.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	PHQ-9 español (forma estadounidense 2005), 9 síntomas más pregunta funcional.
6. Periodo temporal	Últimas dos semanas.
7. Escala/formato de respuesta	0=Nunca a 3=Casi todos los días.
8. Algoritmo de puntuación	Sumar los nueve síntomas 0–3; rango 0–27. La pregunta de dificultad funcional no integra el total. El umbral debe citar la población: el estudio español de atención primaria citado propuso ≥ 8 en su muestra.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	España: N=2.579 en 22 centros de atención primaria; alta consistencia interna; el estudio propuso ≥ 8 como umbral óptimo en esa muestra. No universalizar el corte.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntos de corte de severidad: 5 (Leve), 10 (Moderada), 15 (Moderadamente Severa), 20 (Severa). Generalmente se usa >9 o >10 como corte diagnóstico. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	El formulario local declara permiso general de reproducción/traducción/distribución; conservar texto y atribución.
13. Referencias y fuentes verificadas	Muñoz-Navarro et al. (2022/2023), validación en 2.579 pacientes de atención primaria española, doi:10.1017/S0 033 291 722 002 835, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36 258 639/ ; formulario español local PHQ Screeners.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.